REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS. GARANTIA DO ACESSO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO FORNECIMENTO. **DESPROVIMENTO.**

- O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades têm legitimidade *ad causam* para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a material para realização de procedimento cirúrgico para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

- O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido.

V i s t o s , e t c .

Remessa Oficial originária de sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pocinhos, que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por **Vicencia Maria Galdin**o em face do **Estado da Paraíba,** julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado da Paraíba através de sua Secretaria de Saúde, ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em fornecer gratuitamente para a paciente VICENCIA MARIA GALDINO - os medicamentos "LUCENTIS" (quantidade indeterminada, uso contínuo), em conformidade com a liminar antes concedida e ora mantida, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, § 1° do Código de Processo Civil. (Id. 9941665 – Pág. 13)

Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos para serem analisados, por força do reexame necessário.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e desprovimento da remessa (Id. Núm. 10012366).

É o que importa relatar.

Decido.

De início, ressalto que a assistência à saúde e a proteção à vida são competências **comuns** dos entes federados (art. 23, II, CF).

Tanto é assim, que segundo a Carta Magna, a saúde ***"é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*** (art. 196).

Diante dessas disposições, observa-se que o Sistema Único de Saúde garante o fornecimento de cobertura integral aos seus usuários – não importando se de forma coletiva ou individualizada, como no caso em apreço –, e por todos os entes estatais da Administração Direta.

Sendo assim, o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade *ad causam* para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

Isto posto, exsurge dos autos, que **Vicencia Maria Galdin**o**,** necessita do uso contínuo do medicamento denominado "LUCENTIS", destinado ao tratamento de "baixa acuidade visual central acentuada nos dois em decorrência

da existência de degeneração macular relacionada a idade (CID H35.3)", razão por que ingressou com a presente demanda com a finalidade de obtê-lo, considerando a sua impossibilidade financeira para arcar com os custos de sua aquisição.

Pois bem.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida – bem fundamental para o qual deve o Poder Público direcionar suas ações – há de prevalecer em relação a qualquer outro interesse estatal, já que sem ele os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito.

O direito à saúde foi consagrado pela Constituição Federal de 1988 como direito fundamental do cidadão, corolário do direito à vida, bem maior do ser humano.

O art. 196 do Texto Constitucional estabelece que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

A respeito disso, a melhor orientação é aquela que considera que as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma regulamentadora.

Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, consigna que ***"as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [..] II - atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] § 1º - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".***

Insta ressaltar, também, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da possibilidade de o Poder Judiciário intervir na implementação de Políticas Públicas, visando a concretização de normas constitucionais veiculadoras de direitos sociais, atuando na preservação do "*mínimo existencial humano*", definido por ***Luiz Edson Fachin*** como o conjunto de situações materiais imprescindíveis a vida digna do ser humano. Vejamos a ementa de recente julgado do Excelso Pretório:

> **"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES" (OU DA "LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF,**

ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS "ESCOLHAS TRÁGICAS" – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. (…)" (ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 PUBLIC 13-11-2014)

Como se vê, é a própria Carta Constitucional que impõe o dever de proceder à reserva de verbas públicas para atender a demanda referente à saúde da população, descabendo sustentar a ausência de destinação de recursos para fugir à responsabilidade constitucionalmente estabelecida. O aparente conflito entre o direito individual da recorrida de receber o tratamento de que necessita e o interesse público de se atender aos cronogramas orçamentários, poderia ser facilmente dirimido pela Administração Pública, mediante uma melhor alocação dos recursos públicos para suprir as necessidades emergenciais, haja vista a inoperância estatal em diversas áreas sociais, dentre elas, a saúde e a educação.

Feito este registro, ante um direito fundamental, inexiste outra justificativa de natureza técnica ou burocrática do Poder Público. Nesse caso, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e fazer prevalecer contra essa prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo que razões de ordem ética impõe ao julgador uma só opção: o respeito à vida.

No mesmo sentido, vem decidindo os Tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE (ART. 196 DA CR/88) - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - RECHAÇADA - AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP-1681690/SP E RESP-1682836/SP (TEMA 766) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA DE OBJETO - REJEITADAS - MÉRITO - EXAMES MÉDICOS - PACIENTE QUE NECESSITA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - LESÃO MELANOCÍTICA NO OLHO DIREITO - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

- "O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se trata de direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)". Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP-1681690/SP e RESP-1682836/SP (Tema 766).

- Não há inadequação da via eleita se o pleito indicado na petição inicial do mandado de segurança é viável à concessão do provimento judicial desejado.

- A precariedade das decisões que concedem tutela antecipada/liminar decorre do seu caráter nitidamente sumário e provisório, sendo imprescindível, para a sua eficácia, a análise do mérito.

- Em sendo a saúde indissociável do direito à vida, a Constituição da República preconiza que o Poder Público deve oferecer atendimento integral ao cidadão, suprir as suas necessidades individuais de acordo com as peculiaridades do caso, e envidar todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento.

- Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento do exame de tomografia computadorizada para a aferição de eventual metástase, a paciente portado ra de neoplasia maligna do olho direito, quando comprovada a urgência e necessidade, bem como a impossibilidade de arcar com o seu custeio.

- É possível a imposição de multa diária em sede de mandado de segurança, em especial, quando sua natureza jurídica visa a compelir o cumprimento de ordem judicial.

- Recurso desprovido.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0148.17.002173-4/002, Relator(a): Des. (a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Portanto, a sentença objeto do reexame necessário está em harmonia com a dogmática jurídica vigente, impondo sua manutenção.

Em face do exposto, monocraticamente, **NEGO PROVIMENTO À REMESSA,** mantendo incólume a sentença.

Publique-se. Intimem-se

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

RELATORA

Assinado eletronicamente por: MARIA DAS GRACAS MORAIS GUEDES
23/03/2021 10:09:43
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 43510957

21032310094300000000004

IMPRIMIR GERAR PDF